

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria Técnica
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Serviços Especiais
Gerências Distritais da Atenção Primária

Nota Técnica Conjunta nº 03/2024 – SES.DAS / SES.DTE

Assunto: Implantação do instrumento referente à Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) utilizado pela Equipe Multiprofissional (eMulti) da Atenção Primária à Saúde (APS) para auxiliar os médicos pediatras da unidade de saúde de referência

Considerando a instituição do Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro do Autismo-NAIPE DI/TEA (conforme disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informação - SEI N° 22.0.178204-5);

A Diretoria de Assistência à Saúde, as Gerências Distritais da Atenção Primária, por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, elaboram e publicam esta nota técnica a ser seguida pelos profissionais da eMulti da APS do Município de Joinville, que realizarão apoio aos médicos pediatras da unidade de saúde de referência.

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE EMULTI

Considerando a validação da Diretoria Técnica da Secretaria da Saúde do Município de Joinville no que se refere às atribuições e competências dos Médicos (conforme a “Nota Técnica Conjunta nº 02/2024 - SES.DAS/SES.DTE - “Atribuições e Avaliação clínica médica aos usuários com alta suspeita de DI e/ou TEA na RAS”, disponível no processo SEI N° 24.0.189486-6), o médico pediatra da APS poderá solicitar, se necessário, apoio da equipe eMulti de referência para auxiliar na sua conduta, preferencialmente aos profissionais Terapeuta Ocupacional ou Psicólogo.

Quando acionada, a equipe eMulti deverá seguir com a aplicação do instrumento de apoio referente à alta suspeita de DI/TEA - **“Entrevista estruturada para investigação clínica na suspeita de DI/TEA - Equipe Multiprofissional - APS”** (Anexo 1).

REFERÊNCIAS

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Nota Técnica Conjunta nº 02/2024 - SES.DAS/DTE.** Atribuições e Avaliação clínica médica aos usuários com alta suspeita de Deficiência Intelectual (DI) e/ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Joinville - SC: 2024;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro do Autismo - NAIPE DI/TEA.** Joinville - SC: 2024.



Anexo 1. Entrevista estruturada para investigação clínica na suspeita de DI/TEA - Equipe Multiprofissional - APS

ENTREVISTA ESTRUTURADA PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA NA SUSPEITA DE DI/TEA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS	
Número do Prontuário do Usuário:	
Data de nascimento:	Idade:
Responsável pelas respostas fornecidas na entrevista: <i>*Nome e vínculo parental</i>	
Motivo do encaminhamento:	
☐ Suspeita de Deficiência Intelectual (DI) ☐ Suspeita de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)	
Com quem reside a criança?	
Descrever todas as pessoas que residem na mesma casa com a criança (exemplo: pai, mãe, avós, etc.):	
O Usuário já realizou exames prévios para investigação da suspeita?	
() SIM () NÃO	Quais? () Exames de neuroimagem () Exames auditivos () Investigação Genética () Avaliação neuropsicológica () Outros
Medicações em uso:	
1 - DADOS PRÉ, PERI E PÓS-NATAIS	
Intercorrências Pré-natais: ☐ Ausência de acompanhamento pré-natal; ☐ Pessoa em situação de rua; ☐ Infecções maternas; ☐ Sangramentos; ☐ Uso de álcool, tabaco ou outras drogas pela mãe; ☐ Traumas físicos; ☐ Diabetes gestacional ou eclâmpsia; - Demais intercorrências relevantes na gestação: _____	
Intercorrências Perinatais: ☐ Parto Normal ☐ Cesárea ☐ Idade gestacional em semanas: _____ ☐ APGAR: 1º minuto: _____ 5º. Minuto: _____ ☐ Baixo peso? ☐ Alterações de perímetro cefálico? ☐ Hipóxia ou Anóxia? ☐ Precisou de O2? ☐ Internou em UTI?	
Intercorrências Pós-natais (considerar até 6 semanas após o parto) ☐ Alterações no teste do pezinho ☐ Asfixia ☐ Icterícia ☐ Quedas ou traumas ☐ Infecções ☐ Convulsões ☐ Dificuldades na amamentação ocasionando prejuízo nutricional ☐ Ausência de acompanhamento em puericultura	



2 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ATÉ 5 ANOS DE IDADE)

Alimentação:

- Há suspeita de desnutrição ou obesidade?:
 - ☐ Desnutrição
 - ☐ Obesidade
 - ☐ Não há suspeita
- Amamentação (primeiros 6 meses):
 - ☐ leite materno
 - ☐ fórmula
 - ☐ outros (mingau, leite de vaca, etc)
- Alguma dificuldade na amamentação? (pega alterada, deglutição, afogamentos, refluxo):
Quais? _____
- ☐ Fez uso de mamadeira (até que idade: _____)
- ☐ Fez uso de chupeta (desde que idade: _____)
Motivo do uso da chupeta:
 - ☐ para induzir sono
 - ☐ para acalmar
 - ☐ uso constante
- Introdução alimentar:
 - ☐ Idade que começou a se alimentar com frutas: _____
 - ☐ Idade que começou a se alimentar com alimentos salgados (sopas, papinhas): _____
 - ☐ Intercorrências na introdução alimentar: _____
- Atualmente possui bom apetite?: () Pouco () Normal () Muito voraz
- ☐ Criança se alimenta assistindo TV, Celular ou demais eletrônicos?
- ☐ Possui alergia alimentar diagnosticada? (celíaca, APLV, corantes)
- ☐ Possui algum ritual específico alimentar que não tenha sido induzido e sustentado pela família?
- Possui alguma seletividade alimentar que exceda as de características típicas do desenvolvimento infantil? () SIM () NÃO Se sim, quais? _____
- Outras considerações relevantes acerca da alimentação: _____

Sono (qualidade do sono):

- Quando bebê (até 1 ano 11 meses e 29 dias):
 - ☐ Dormia no próprio berço?
Onde?
 - ☐ em quarto próprio
 - ☐ no quarto dos pais
 - ☐ Dormia na cama dos pais?
 - ☐ Resistência ao sono?
 - ☐ Sono tranquilo
 - ☐ Sono agitado
- Atualmente:
Onde a criança dorme?:
 - ☐ em quarto próprio
 - ☐ O quarto é compartilhado com irmãos ou familiares?
 - ☐ no quarto dos pais
- ☐ Dorme na cama dos pais?
- ☐ Resistência ao sono?
- ☐ Sono tranquilo
- ☐ Sono agitado



Linguagem:

- Comunicação até 18 meses:

- ☐ Apontar para solicitar ajuda ou demonstrar interesse;
- ☐ Fazer gesto de sim ou não com a cabeça;
- ☐ Dar “tchau” com as mãos;
- ☐ Imitar “gracinhas”;
- ☐ Levantar os braços para pedir colo;
- ☐ Bater palmas

- Comunicação verbal:

Com que idade a criança falou as primeiras palavras?: _____

Com que idade a criança formulou frases simples? (Ex. Água mamãe - para pedir água): _____

- ☐ A criança costuma apontar para o que deseja?
 - ☐ sem comunicação oral
 - ☐ com comunicação oral
 - ☐ Os pais interpretam sem que a criança precise falar?
- ☐ Criança exposta ao uso de eletrônicos (celular, tablet, etc.)?
- ☐ A criança reage quando chamada pelo nome?

- Após 3 anos de idade:

- ☐ A articulação da fala é inteligível?
 - ☐ ausência de comunicação oral
 - ☐ Inventa palavras ou vocalizações?
 - ☐ alterações articulatórias
 - ☐ acompanhada por fonoaudiologia?
- ☐ Criança ainda apresenta características de ecolalia (considerar aqui o início da comunicação oral e descartar a correlação com a ecolalia comum no desenvolvimento típico)?
- ☐ A criança compreende a diferença entre “o eu” e “o outro”?
- ☐ Percebe-se alterações na entonação da fala (ritmo, timbre)?
- ☐ A criança ainda pega a mão do adulto como se fosse uma ferramenta para abrir/alcançar algo?
- ☐ A criança segura o rosto do adulto para fazê-lo olhar em determinada direção?
- ☐ Costuma expressar suas opiniões, preferências ou desejos?

Desenvolvimento Neuromotor:

- Com que idade a criança:

Sentou sem apoio: _____

Engatinhou: _____

Deambulou: _____

Desfralde diurno: _____

Desfralde noturno: _____

- ☐ A criança apresenta desequilíbrio, dificuldade para correr e escalar?
- ☐ A criança apresenta dificuldade para jogar bola, pular, chutar?
- ☐ A criança apresenta dificuldade de manipulação de objetos com os dedos (jogo de montar, encaixar)?
- ☐ A criança apresenta agitação psicomotora intensa/hiperatividade?
- ☐ Compreensão de orientação espacial (em cima, em baixo, grande, pequeno, dentro, fora)



Relação com o brincar:

- ☐ A criança tem hábito de brincar?
 - Qual a brincadeira preferida?: _____
- ☐ Suas brincadeiras têm funcionalidade?
- ☐ Tem um brinquedo favorito? Qual?: _____
- ☐ A família tem hábito de ler histórias para a criança?
- ☐ A criança brinca de faz de conta?
- ☐ A criança é exposta ao uso de aparelhos celular, tablet, etc.?
- ☐ A criança brinca ou convive com crianças da mesma idade?
- ☐ A criança costuma brincar com jogos ou atividades cognitivas (peças de encaixe, jogo da memória, quebra-cabeças, etc.)
- ☐ A criança demonstra percepção de perigo nas brincadeiras?
 - Percepções do profissional acerca de alterações de funcionalidade no brincar:

3 - ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

- Banho:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Uso do banheiro:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Higiene após uso do banheiro:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Para alimentação (uso de talheres, preparar um sanduíche, buscar alimentos no armário/geladeira)?:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Higiene Bucal:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Vestuário:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- ☐ A criança auxilia em alguma atividade da rotina? (Ex. Guardar brinquedos, arrumar a mesa, colocar roupa suja no cesto)
- ☐ A família sustenta ou infantiliza o processo de autonomia para AVDs?

4 - SOCIABILIDADE/AFETIVIDADE

- ☐ A criança mantém contato visual consistente ao interagir com outras pessoas?
- ☐ Faz manifestações de carinho e afeto?
- ☐ Demonstra preocupação se os pais estão tristes ou doentes?
- ☐ A criança demonstra interesse na interação com outras crianças?
- ☐ A criança manifesta reação afetiva diante de pessoas próximas ou conhecidas?
- ☐ A criança manifesta excessiva reação quando se separa dos pais?



5 - ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E SENSORIAIS

- ☐ Demonstra excessiva resistência a mudanças na rotina pessoal/da casa combinadas com crises de conduta?
- ☐ Demonstra rigidez na rotina
- ☐ Demonstra apego por objetos pouco comuns para a idade (carrega consigo)?
- ☐ Percebe-se riso descontextualizado com frequência na rotina?
- ☐ Apresenta crises de irritabilidade com autoagressão ou heteroagressão?
- ☐ Costuma abrir e fechar portas, liga/desliga interruptores de luz, intenso interesse por objetos que giram (máquina de lavar, ventilador, veículos em geral)?
- ☐ Costuma fazer movimentos excessivos com dedos e mãos junto ao rosto?
- ☐ Costuma fazer movimentos das mãos/braços (flapping)?
- ☐ Nota-se hipersensibilidade a barulhos comuns?
- ☐ A criança caminha na ponta dos pés, balança-se ao andar?
- ☐ Observa detalhes dos brinquedos próximos aos olhos?
- ☐ Costuma fazer movimento de pêndulo com o corpo?
- ☐ Há interesse pelas propriedades sensoriais dos objetos (cheiro/textura)?
- ☐ Percebe-se alteração na percepção da dor (ou limiar muito atípico de tolerância)?

6 - CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM ESCOLAR

Convivência escolar:

- Desde que idade a criança frequenta a escola? _____
- Período que frequenta a escola:
 - ☐ manhã
 - ☐ tarde
 - ☐ integral
- Considerações acerca da adaptação: _____

Aprendizagem escolar:

- ☐ Reconhece cores
- ☐ Reconhece formas
- ☐ Reconhece números e letras?
- ☐ Associa número a quantidade?
- Alfabetização:
 - ☐ Não alfabetizada
 - ☐ Em processo de alfabetização
 - ☐ Alfabetizada
- Considerações acerca da alfabetização: _____

7- PARECER DO PROFISSIONAL ENTREVISTADOR

Descrever o parecer:

Validada suspeita? ()SIM ()NÃO

